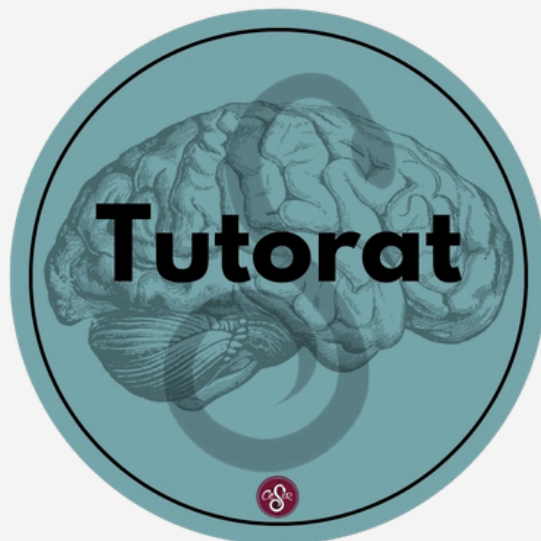


Les troubles de l'humeur

La bipolarité



La bipolarité

La thymie

La thymie (humeur) devient pathologique si:

Fixation dans un état extrême de tristesse= **dépression**
ou d'euphorie= **manie**

Ou variation très rapides entre des états extrêmes

Les troubles de l'humeur
peuvent être **chroniques**,
continus ou **intermittents**



La bipolarité

définition

“ Alternance dans le temps d'épisodes (hypo)maniaques, de phases dépressives et phases euthymiques

La rechute très fréquente

En moyenne: 50% du temps symptomatiques, 30-40% du temps en dépression

Trouble multifactoriel: génétique, neurologique, développemental, psycho-social et environnemental

La moitié des personnes atteintes de troubles bipolaires ont subi un traumatisme dans l'enfance



La bipolarité

Le syndrome maniaque

Exaltation de l'humeur

Hypersthénie: absence de fatigue, grande énergie, la personne ne peut (quasiment) pas dormir pendant des jours

Modification du contenu de la pensée:

Idée de grandeur, sentiment de toute puissance

Hyperoptimisme

Multiplication des initiatives et projets

Anosognosie (ignorance de l'état pathologique)

Accélération psychomotrice

Troubles des conduites instinctuelles (insomnie sans fatigue, hyperphagie, libido ++)

Délire mystique ou mégalomane

>7 jours

Altération du fonctionnement social et professionnel

**Episode hypomaniaque:
sd maniaque
atténué, sans
délire**



La bipolarité

L'épisode mixte

>7 jours

**Association de symptômes dépressifs et de symptômes
maniaques**

**Peuvent coexister et s'alterner rapidement (quelques
heures)**

Changements d'humeur soudains

Forte impulsivité

Risque suicidaire très élevé



La bipolarité

Prise en charge

Pluridisciplinaire: médecin, infirmiers, psychologue,
assistante sociale

Personnalisée

Empathie, alliance thérapeutique, psychoéducation

**Prévention des risques (suicidaires, prise de
toxiques...)**

Prise en charge des proches

Hospitalisation si risque suicidaire (SL, SDT, SDRE)

Ou suivi en rendez-vous aux CMP/CATTP/HDJ

**Bilan paraclinique initial: biologique, ECG, toxiques
urinaires, parfois une imagerie cérébrale**

Prise en charge sociale



La bipolarité

Traitements

Traitement médical:

Traitement de fond: **thymorégulateurs** (régulateurs de l'humeur)

À la fois pendant les phases maniaque et dépressives

3 types:

Lithium

Antiépileptiques (valproate, iamotrigine...)

Certains antipsychotiques: aripiprazole, olanzapine, quétiapine



Les traitements

Surveillance

Pour les thymorégulateurs en général:

- **Tolérance**
- Risque de **surdosage** => dosage lithiémie
- **Neurologique**: tremblements, trouble de conscience, syndrome cérébelleux (troubles des mouvements, coordination...)
- Bilan rénal, thyroïdien, NFS, ECG
- Risque de sd sérotoninergique (confusion, agitation)
- Bilan hépatique
- Dermatologique
- Métabolique (prise de poids, glycémie...)
- Risque d'hyponatrémie
- Rigidité, tremblement, T°
- Augmentation prolactine, dysfonction sexuelle

